

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	大量灌腸技術（清潔灌腸） Large Amount Enema (Cleaning Enema)				
編號	A31000-Q05-W-A28	制定者	N09 陳美如	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.9 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作大量灌腸（清潔灌腸）技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.軟化糞便並刺激腸道，使糞便易於排出，以解除便秘。
- 2.手術前腸道清潔。
- 3.下腸道接受檢查前之腸道準備。

（二）用物準備

- 1.治療盤 1 個、布中單或看護墊 1 塊。
- 2.Enema bag 一付。
- 3.彎盆（視需要）、衛生紙（數張）、尿布（視需要）、Jelly1 包。
- 4.溶液（依醫囑及年紀決定）。
- 5.點滴架 1 支、便盆 1 個（視需要）、清潔手套 1 雙。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對電腦 HIS 護理系統於護理執行，核對預定醫囑，並於核對狀態核簽“正確”。	
2. 正確使用兩種以上辨識方法辨識病人，向病人解釋目的及過程，詢問是否需要便盆或便盆椅。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭

主題名稱	大量灌腸技術（清潔灌腸）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A28	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
	卡）並核對手圈。
3. 工作前洗手。	
4. 準備用物：	
(1)取可拋棄式的『Enema bag』。	院內統一尺寸為：24FR。
(2)取適量 jelly 置於衛生紙上。	
(3)依醫囑取適量溫水，放入 Enema bag 內，500 或 1000 cc。	以手前臂內側測試溫度以不燙手為準，溫度太高會傷及腸黏膜或可能引起昏厥，太低則可能使肛門肌肉收縮痙攣。
(4)將其餘用物（彎盆、衛生紙、清潔手套、jelly）置於治療盤內。	
5. 準備病人：	
(1)進行病人辨識再次核對病人。	
(2)將用物攜至病人單位，圍床簾、關窗簾，以被單代替被蓋。	注意病人隱私，於床簾外夾”治療中請勿打擾”小牌。
(3)協助病人將褲子脫至膝處，並採左側臥，且使臀部靠近床邊予以適當暴露，適當覆蓋病人。	左側臥可使病人放鬆腹肌，水流易順著大腸之彎曲方向流入。
(4)將布中單或看護墊，墊於病人臀下。	
(5)將點滴架置於床尾，適當控制管夾距離處，掛上 Enema bag，保持液面至肛門之垂直距離約 45～60 公分，以維持適當的壓力與流速。	若壓力太小，溶液不易流入；若壓力太大，糞便未軟化時，已引起排便作用，則無法清除糞便，嚴重時，可能使腸道破裂或造成其他損傷。
6. 執行灌腸：	
(1)戴上手套，以 Jelly 潤滑肛管前端約 5～10 公分。	注意勿使塞住肛管孔。
(2)持 Enema bag 前端於彎盆或圾垃筒上方，鬆開管夾，進行排氣動作，排出少量溶液，再將管夾關閉。	預防空氣流入而引起腹脹不適。
(3)請病人微張口或講“啊”或與病人談話。	分散病人注意力，以助病人放鬆腹肌。
(4)手持衛生紙，輕輕撥開肛門區的肌肉露出肛門口，另一手將肛管輕輕插入肛門。	插入深度：成人：7.5～10 公分；兒童：5～7.5 公分；嬰兒：2.5～3.75 公分。
(5)一手固定 Enema bag 的肛管，另一手打開管夾，使液體緩緩流入。	若流速太快，會刺激結腸引起排便反應，無法達到效果。
(6)告知病人若感覺腹部疼痛或想解便時，需告知護理師（可減低流速或暫停灌入），隨時觀察病人反應。	過程中須隨時注意病人反應，適時給予關心。
(7)待溶液快流完時關閉管夾，一手持衛生紙壓住肛	可用衛生紙壓住肛門，防止液體外流。

主題名稱	大量灌腸技術（清潔灌腸）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A28	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
門，另一手捏緊 Enema bag 的肛管，並輕輕抽出肛管。	
(8)衛教病人儘量忍住便意 5~10 分鐘，使大便有足夠的時間軟化。	
(9)以衛生紙包住 Enema bag 的肛管前端，棄置感染性垃圾筒內。	
(10)病人無法再保留灌腸液或無法忍受時，立刻協助解便。	置衛生紙及呼叫鈴於病人易取得處，予病人充足時間解便，留意病人是否為跌倒高危險群採取相關防護措施。。
7. 灌腸後之處理：	
(1)整理用物。	
(2)待病人解便後，觀察排泄物性質，如需檢驗則先留標本後再倒掉。	
(3)協助病人清潔並穿好衣褲。	
(4)移去布中單或看護墊。	
(5)整理病人單位。	
(6)攜出之各用物，依醫院規定垃圾分類處理。	
(7)洗手。	
(8)核對電腦 HIS 護理系統於執行狀態核簽“正確”。	護理記錄內容應包括：灌腸時間、使用溶液、灌入量、排泄物的性質、效果及病人反應，排便次數、性狀、顏色，視需要於資訊系統紀錄排出量。

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	大量灌腸技術（清潔灌腸）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A28	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/6

六、參考資料

- （一）陳淑齡（2023）．排泄需要．於蘇麗智等編著，實用基本護理學下冊（九版，375-430 頁）．台北市：華杏。

七、附件

（略）

主題名稱	大量灌腸技術（清潔灌腸）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A28	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日通過護理部技術標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.10.23	2.1	修正第三項第(三)目之 1 及 8(8)部份內容。	101 年 10 月 23 日通過護理部技術標準委員會。
101.12.26	2.2	1. 名稱大量灌腸法（肥皂水灌腸）改為（清潔灌腸）。 2. 用物準備部份刪修。 3. 內容修改：將肥皂水灌腸改為清潔灌腸。	101 年 12 月 26 日通過護理部技術標準委員會。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.04.03	3.1	刪除：準備用物 3.配置肥皂水溶液： A.注入適量之溫水於灌腸袋內。	102 年 04 月 03 日通過護理部技術標準委員會。
103.03.18	3.2	說明(三)步驟及要點說明內容部份修辭及 7.(8)增修：於護理資訊系統排便欄內點選灌腸，並選擇排便次數、性狀、顏色	103 年 03 月 18 日通過護理部技術標準委員會。
104.03.17	3.3	1. 第三項第(二)(三)目步驟及要點說明部份內容更新。 2. 修正第六項參考資料及版本。	104 年 03 月 17 日護理部技術標準委員會通過
105.03.15	3.4	1. 用物準備移除溫度計。 2. 第三項說明內容部份刪修。 3. 修正第六項參考資料及版本。	105 年 03 月 15 日護理部技術標準委員會通過
106.03.14	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.05.09	3.5	第三項第三目步驟及要點說明內容修訂。	107 年 05 月 09 日護理長會議通過
108.03.18	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目步驟及要點說明內容修訂。 3. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 18 日護理技術組會議通過；108 年 04 月 10 日護理長會議通過；108 年 04 月 23

主題名稱	大量灌腸技術（清潔灌腸）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A28	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
			日督導會議通過公布。
109.04.21	3.7	1. 第三項第二目之 3：新增尿布（視需要），刪除 Xylocaine。 2. 第三項第三目步驟及要點說明內容修辭修訂並刪除 Xylocaine。	109 年 03 月 16 日護理技術組會議通過；109 年 04 月 08 日護理長會議通過；109 年 04 月 21 日督導會議通過公布。
110.03.15	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.03.21	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.03.20	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.16	3.8	1. 第三項第二目用物準備刪除凡士林。 2. 第三項第三目步驟及要點說明刪除凡士林	113 年 03 月 18 日護理技術組會議通過；113 年 04 月 10 日護理長會議通過；113 年 04 月 16 日督導會議通過公布。
114.03.17	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.9	1. 主題內容統一修訂為技術 2. 第六項參考資料更新	115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過；115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。